Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vfaz@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5112537-54.2021.8.21.0001/RS

AUTOR: LUIZA ANTUNES RAMOS
RÉU: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

LUIZA ANTUNES RAMOS ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE e do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alegando possuir diagnóstico de "Plurigo Nodular" (CID10 L28.1). Refere que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Dupilumabe**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade da justiça (evento 9, DESPADEC1).

Acostada nota técnica favorável, foi deferida a tutela de urgência (evento 13, DESPADEC1).

Citado, o Estado contestou alegando a necessidade de observância do Tema 793-STF, com a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, impugnou pela improcedência da demanda (evento 23, PET1).

O Município contestou requerendo a sua exclusão do feito, por não se tratar de medicamento pertencente ao componente básico, logo, não sendo de sua competência o fornecimento. No mérito, também postulou pela improcedência da demanda. (evento 27, CONT1).

A parte autora replicou (evento 30, RÉPLICA1).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de outras provas, manifestaram desinteresse (evento 42, INIC1; evento 44, PET1; evento 47, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 49, PROMOÇÃO1).

Houve pedidos de bloqueio de valores (evento 59, PET1; evento 123, PET1), os quais foram deferidos (evento 61, DESPADEC1; evento 127, DESPADEC1).

Prestadas as contas (evento 88, NFISCAL3; evento 151, NFISCAL2), o Estado nada impugnou.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. PRELIMINARES

I.1 Da Denominação Comum Brasileira

De início, imperioso destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo (*Apelação Cível, Nº 70084379239, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020*).

Neste mesmo sentido é o Enunciado nº 15 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor:

> *As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.*

I.2. Da competência

A questão da competência está superada pela decisão de tutela incidental proferida no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - **Tema 1234**.

Segue o dispositivo da decisão, exarada em 17.04.2023 e confirmada pelo Plenário Virtual do STF, em 18.04.2023:

> *(i)* ***nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:*** *a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza*

cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

*(ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados**: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (grifos acrescidos)*

*(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos **sem sentença prolatada**; diferentemente, os processos **com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)** devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Neste caso, verifico que o medicamento **Dupilumabe** não está incorporado ao SUS. Além disso, a parte autora ajuizou a demanda judicial direcionando o feito ao Juízo Estadual, portanto, incide o item *ii* do Tema 1234 do STF.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

I.3. Da ilegitimidade passiva do Município

Em se tratando de prestações de saúde, a responsabilidade dos entes é solidária. No entanto, na estrutura do SUS existe uma divisão das competências administrativas entre os entes federativos. Em razão disso, poderá o(a) magistrado(a), após a propositura da demanda, direcionar o cumprimento da medida conforme as regras de competências. Neste sentido é a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855.178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019(Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).

No mesmo sentido é o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, na qual participaram os maiores estudiosos do tema no país:

Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Aos Municípios cabe o fornecimento das medicações pertencentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, o que **não é o caso dos autos.** Verifico, pois, a ausência de legitimidade do ente municipal para o cumprimento deste comando judicial.

Diante do exposto, reconheço a **ilegitimidade passiva do Município de Porto Alegre** para responder à presente demanda.

II. DO MÉRITO

II.1. Do direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal. Neste sentido: RE nº 557.548/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 155, publicado em 05.12.2007.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível Nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que ao Judiciário compete fazer cumprir a ordem jurídica.

II.2. Da necessidade do tratamento

A tutela de urgência foi deferida (evento 13, DESPADEC1), a qual abaixo colaciono e passo a ratificar:

"(...) No presente feito, conforme o laudo médico juntado aos autos a parte autor apresenta o diagnóstico de Plurigo nodular (CID10 L28.1), de difícil tratamento, já tendo feito uso dos fármacos Tópicac, Metotrexato, doxepina e também fototerapia; apresenta, atualmente, lesões nodulares acometendo membros inferiores e superiores e tronco com prurido importante. Consoante

laudo médico, essas lesões, se não tratadas adequadamente, são uma porta de entrada para infecções bacterianas, as quais podem ter graves consequências, inclusive serem fatais; o uso do fármaco prescrito visa melhorar significativamente o prurido, melhorando a qualidade de vida da autora, espera-se, ainda, que as lesões de tornem-se mais planas e a pele fique integra.

Verifico, ainda, que a nota técnica elaborado pelo sistema E-Natjus foi favorável ao fornecimento do fármaco, concluindo pela presença de elementos técnicos suficientes a embasar a prescrição do mesmo. Veja-se:

> *"Tecnologia: DUPILUMABE*
>
> *Conclusão Justificada: **Favorável***
>
> *Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de prurigo nodular grave, conforme relatório médico acostado nos autos. CONSIDERANDO que não houve resposta terapêutica aos tratamentos de primeira linha oferecidos pelo SUS já instituídos. CONSIDERANDO as evidências científica disponíveis, favoráveis à indicação da medicação pleiteada.*
>
> *CONCLUI-SE que **há elementos técnicos para sustentar a indicação de dupilumabe para a paciente na presente situação clínica**, não estando bem caracterizada a urgência da solicitação".*

Para a concessão da tutela de urgência se faz imperioso que haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

No caso em apreço, resta suficientemente evidenciada nos autos a necessidade de utilização da medicação pela parte autora.

Diante das alegações médicas, entendo que a não concessão da medicação postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde, na medida em que, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de diminuição dos efeitos decorrentes de sua enfermidade.

Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada, e comprovada a necessidade que possui em receber a medicação na dosagem postulada, de modo a permitir o seu tratamento, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela pretendida.

*Diante do exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para:***

***1 -** Determinar ao **Estado do Rio Grande do Sul** que disponibilize à parte autora, no prazo de **dez (10) dias**, o medicamento **Dupilumabe**, pelo tempo necessário para a realização do tratamento, conforme prescrição médica (outros 10, evento 1)**.** A retirada do fármaco deverá ser feita pela parte autora diretamente na Farmácia de Medicamentos do Estado, mediante a apresentação semestral de receituário médico atualizado. Em caso de falta no estoque, a parte requerida deverá efetuar, **no mesmo prazo referido acima**, o depósito de quantia suficiente à aquisição de três meses da medicação e, após, proceder na regularização do fornecimento."*

No julgamento do **Recurso Especial nº 1.657.156 (TEMA 106),** o STJ estabeleceu que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos via SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: **1)** comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; **2)** incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e **3)** existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso dos autos, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos.

O primeiro requisito resta comprovado pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO7; evento 1, LAUDO8; evento 1, LAUDO9; evento 11, OUT1), que refere à necessidade no uso do medicamento **Dupilumabe** para melhora da patologia da parte autora, e que não houve benefícios com a utilização dos outros fármacos disponíveis no SUS:

Pode ser digitado.

LAUDO MÉDICO PARA AÇÃO JUDICIAL

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO

Nome do paciente: Luiza Antunes Ramos

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO:

CID para o qual será utilizado: L 28.1	
Princípio(s) ativo(s): Dupilumabe	
Apresentação(ões)/Concentração(ões): Seringa 150mg/ml (2 ml)	
Via de administração:	
Em caso de uso parenteral, os insumos e o procedimento de administração/aplicação são cobertos pelo SUS e será feito pelo próprio médico assistente ou pela unidade de saúde responsável ao qual o(a) paciente se encontra referenciado(a)?	(X) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
Posologia: Aplicar 600 mg subcutâneo como dose de indução. Após, fazer aplicações de 300 mg subcutâneo a cada 15 dias.	
Forma de utilização:	( ) uso contínuo/sem pausa (X) uso em ciclos: cada ciclo corresponde a 15 dias
Duração do tratamento:	(X) indeterminado ( ) determinado: pelo período de _____
Caso a posologia cause sobra de medicamento, como partição de comprimidos ou excedentes de líquidos de ampolas, estes deverão ser:	( ) Reaproveitados ( ) Descartados (X) Não se aplica
Registrado na ANVISA?	(X) Sim ( ) Não
Indicação em conformidade com a aprovada no registro da ANVISA?	( ) Sim (X) Não
Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante?	( ) Sim (X) Não
Há evidências científicas de qualidade e atuais sobre a superioridade deste fármaco sobre os tratamentos fornecidos pelo SUS?	(X) Sim ( ) Não
Citar ou anexar.	Em anexo, artigo com série de casos com 3 pacientes tratados e revisão da literatura. Nesses estudos, a maioria dos pacientes apresenta Prurigo nodular recalcitrante, com diversos tratamentos prévios e falhas terapêuticos. Nos pacientes tratados com dupilumabe houve redução visível das lesões e diminuição da sensação de prurido.

HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DO PACIENTE:

O(A) paciente participou ou está participando de ensaio clínico relacionado à patologia em questão?	( ) Sim (X) Não
Em caso afirmativo, o medicamento solicitado integra o ensaio clínico?	( ) Sim ( ) Não
Histórico da doença e situação clínica atual: Paciente com prurigo nodular de difícil tratamento, já fez uso de medicações tópicas, metotrexato, doxepina e também fototerapia sem resposta. No momento, apresenta lesões nodulares acometendo membros inferiores e superiores e tronco com prurido importante. É portadora da patologia há 1 ano e meio.	
Histórico dos tratamentos (medicamentos e outros tratamentos com seus respectivos efeitos causados): Já fez uso de Metotrexato 15 mg/semana por 7 meses, sem resposta. Múltiplos cursos de corticosteroide sistêmico, corticosteroides tópicos, tetraciclina oral, anti-histamínicos, doxepina, sertralina e fototerapia - TODOS sem resposta.	
Tratamentos disponíveis no SUS para a patologia do(a) paciente que **não** foram utilizadas e o porquê: Todas as medicações disponíveis no SUS foram utilizadas, sem resposta.	

Conclusão

Tecnologia: DUPILUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de prurigo nodular grave, conforme relatório médico acostado nos autos.
CONSIDERANDO que não houve resposta terapêutica aos tratamentos de primeira linha oferecidos pelo SUS já instituídos.
CONSIDERANDO as evidências científica disponíveis, favoráveis à indicação da medicação pleiteada.
CONCLUI-SE que há elementos técnicos para sustentar a indicação de dupilumabe para a paciente na presente situação clínica, não estando bem caracterizada a urgência da solicitação.

Há evidências científicas? Sim

O segundo requisito, consistente na insuficiência econômica de arcar com os custos do tratamento, vem amparado no valor da medicação (evento 59, OUT2) e na declaração de hipossuficiência (evento 7, DECLPOBRE2).

Ademais, também preenchido o último requisito, qual seja, registro na ANVISA.

Diante das alegações da parte autora, corroboradas pela documentação juntada aos autos, restou evidente a sua necessidade em receber o tratamento pleiteado, pois indispensável à manutenção de sua saúde.

Ante o exposto:

a) Reconheço a **ILEGITIMIDADE PASSIVA** do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, e **JULGO EXTINTO** o processo sem resolução de mérito em relação a este, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e

b) **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos por LUIZA ANTUNES RAMOS contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento do medicamento **Dupilumabe,** com a periodicidade e dosagem determinadas pelo médico, e por tempo indeterminado.

No mais, ante a ausência de impugnação do Estado (evento 94, PET1; evento 158, PET1), **HOMOLOGO** as contas prestadas nos Eventos 88 e 151.

A prescrição médica deverá ser atualizada de seis em seis meses, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria Estadual da Saúde do RS – Farmácia de Medicamentos do Estado ou outro local - pois apesar da indicação de uso contínuo, há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado.

Isento o Estado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o Estado ao pagamento das **despesas processuais**, previstas no artigo 84 do CPC e no artigo 14 e seguintes da Lei nº 14.634/14, bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança das despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Caso interposta apelação e havendo pedido de bloqueio de valores, considerando a necessidade de remessa dos autos à segunda instância, deverá a parte autora distribuir cumprimento provisório de sentença em autos apartados.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 1/9/2023, às 14:56:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10045068570v9** e o código CRC **24f9b3cc**.